



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : برلنتى على الفرماوى حبيب

العنوان : برج بدر 1 المربوطية
العمراتية الجيزة

الحي / المدينة : مطاي

المحافظة : المنيا

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 28010262403042 رقم التليفون : 01068412647

العمر(تاريخ الميلاد) : 26-10-1980 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....) المقر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: برلتي على الفرماوى جيبى National ID: 28010262403042	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

برلنتى
على الفرماوى حبيب احمد
برج بدر ١ - المربوطيه
العمرانيه - الجيزه

١٩٨٠/١/٢١ ٢٨٠١٠٢٦٢٤٠٣٠٤٢
IC7961593

٢٠١٩/٠٨ ٢٨٠١٠٢٦٢٤٠٣٠٤٢
حاصله على ليسانس اداب
أنثى مسلمة
محمد محمد عبدالمقصود محمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٨/٠٣

١

MRN: 20224005768
Patient Name: Birlinti ALI KALW HABEB

D.O.B: 26/10/1980
IC No.: 28010262403042
Sex: Female
Location: Surgical Oncology 1

SURGICAL PATHOLOGY

Biopsy Small - (1 Site)

Specimen Id	992401290042	Collection Date	29/01/2024 07:07 PM
Accession No	Z-SUR24-200175	Received Date	29/01/2024 07:07 PM
Sample Type	Tissue	Doctor	Mohamed Fathy Abdelfattah Abdelrahman

Referring Specialty :
Radiology
History, Relevant Clinical Findings & Previous Inv. Results:
Reason for Order:
Surgical Pathology Exam

Type of Request :
Regular
Side of Procedure Done:
Right

Clinical Information

RT breast malignant looking BIRADS5 mass lesion.

Gross Picture

4 cores 1-1.5 cm.

Microscopic Picture

A case of invasive duct carcinoma, grade III. No DCIS component nor lymphovascular emboli were detected. Foci of necrosis are seen. Stroma is desmoplastic with mild inflammatory cell reaction.

Diagnostic Summary

Tumour type:

Invasive duct carcinoma, grade III.

Laterality

Right

Specimen type:

U/S guided Tru-cut biopsy.

Location

Histological grade

Mitosis score (1-3):

2

Tubular formation score (1-3):

3

Nuclear grade (1-3):

3

Histological grade (1-3):

3

Diagnosis

Right breast,TRU-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, grade III.

Comments

ER, PR & HER-2 are ordered.

Biopsy reporting category

Name: برلنتى علي الفرماوي		
MR. : 3267		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 45-year-old female with triple-positive invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast, estrogen receptor (ER) 5/8 and progesterone receptor (PR) 3/8. She received eight cycles of adjuvant chemotherapy consisting of four cycles of doxorubicin/cyclophosphamide (AC) followed by four cycles of docetaxel (taxotere) and a phesgo regimen. Subsequent to chemotherapy, she underwent breast conserving surgery (BCS) in August 2024 and received adjuvant radiotherapy (RT). She was then treated with KADCYLA (trastuzumab deruxtecan) for 12 cycles, with a port in place, and continued on Zoladex (goserelin) and Femara (letrozole). She is currently scheduled to continue Zoladex and Femara for an additional three months. The patient is undergoing a new annual evaluation for a thyroid nodule classified as TIRADS IV. She has had a fine-needle aspiration cytology (FNAC) performed, and the results are pending. She is continuing her hormonal therapy with Zoladex and Femara, with a plan to reassess after three months. The patient is currently receiving Zoladex and Femara with a planned duration of three months, with the next visit scheduled after this period.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name	: الأستاذة / برلنتي علي الفرماوي حبيب احمد	Request No.	: 13004846
Patient No.	: 28010262403042	Request Date	: 26/08/2024
Path No.	: SR-1230/24	Verification Date	: 02/09/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer (post NACT) .
Nature of the specimen: Slide revision.

Gross Examination:

- 1 paraffin block and 13 slides were received.

Microscopic examination:

- Histological type: Residual viable tumor tissue detected (<1mm).
Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/18).
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic near Complete response

Diagnosis:

Right breast cancer (post NACT) :

- Residual viable tumor tissue detected (<1mm).
- No DCIS.
- Free margins
- Free nipple and areola
- Free L.Ns (0/18)
- Pathologic near complete Response
- Stage : ypT1mi , ypN0

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Menna Nabil.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 19/09/2024 09:51:34

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Populationالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : برنثش علي الترماني حبيب

Sex:

3- Medical number:

Female

83186930

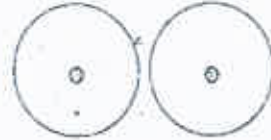
Old Med :

Old Med :

470-2024

2-ID number:

Patient Age : 44 Y



Family history

Family history

Phone

Phone

01068412647

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

19/09/2024 ☐

Co morbidity

Co morbidity

Menopausal
statusMenopausal Status
MENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

IDC

5/8

3/8

3

BX COMMENT

ER COMMENT

PR COMMENT

Her 2 Neu COMMENT

SISH COMMENT

GIII

T

N

M

CT2

0

0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

CLIPS INSERTED

pt finished 8 cycles chemo(4 AC + 4 taxotere , phesgo)

with good clinical response

rt BCS:free margin , nipple , areola

YPT1MIC NO

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

1- ADJUVANT KADCYLA X 12

2-PORT

3- ADJUVANT ZOLADEX AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د. محمد / د. محمد	RADIOLOGY	RADIOLOGY د. رافع البدر
SURGERY	SURGERY د. محمد	PATHOLOGY	PATHOLOGY د. محمد
Psychiatric	Psychiatric د. محمد	Nutrition	Nutrition د. محمد

PATIENT NAME: Birlinti ALI KALW HABEB

GENDER: Female

DATE : 14-Jan-2024 02:18 PM

PATIENT ID: 20224005768

AGE: 43 y

ORDER: 2701074

Report:

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE NECK,
CHEST, ABDOMEN AND PELVIS****1-NECK:**

- Normal appearance of the nasopharynx, oropharyngeal and laryngeal air spaces.
- No glottic, supra or infra glottic mass lesions.
- Intact cartilaginous skeleton of the larynx.
- Normal appearance of submandibular, parotid salivary glands.
- No neck soft tissue mass lesions.
- Two right thyroid lobe iso and hypodense nodules the larger measuring 13 X 12 mm.
- Normal appearance of the neck muscles & vessels.
- No pathologically enlarged cervical lymph nodes.
- Variable degrees of mild pansinusitis sparing the frontal sinus.
- Prominent right supraclavicular lymph node measuring 8 X 5 mm.

2- CHEST:

- Right breast upper aspect irregular spiculated mass lesion with central cystic degeneration, it is measuring 29 X 27 mm.
- Prominent right axillary level I and II lymph nodes; the largest seen at level I measuring 20x10 mm in axial dimensions.
- Enlarged right internal mammary lymph nodes, the largest measures 17 X 6 mm.
- Few bilateral scattered pulmonary nodules with some of them show internal calcification mostly representing post granulomatous sequel.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

3- ABDOMEN AND PELVIS:

PATIENT: Birlinti ALI KALW HABEB, 20224005768, Female, 43 y

Report version 4, 10-Feb-2024 12:21 PM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري، الحيرةمستشفى بهية الشيخ زايد
ع. 11، الدبي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

[ID:TYPE:CT_SCAN]

Medical No. : 9306

Patient's Name: Barlanti Ali El-Farmawy Habib

Date: 2026-09-15

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



MULTI-SLICE POST CONTRAST AXIAL CT SCAN OF THE CHEST AND ABDOMEN REVEALED:

Known case of right breast cancer underwent CBS on follow up.

Chest findings

- Bilateral basal calcified pulmonary nodules ...likely Old granuloma.
- Middle lobe subsegmental collapse of the lateral segment with air bronchogram.
- No detected suspicious pulmonary nodules or masses.
- Normal central trachea with no lesions inside. Normal main bronchi.
- Normal both hilar region. No hilar masses or lymphadenopathy.
- Clear pleural surfaces with no evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size, no pericardial effusion.

Abdomen and pelvis findings

- Mild enlarged fatty liver. No definite enhancing focal lesions lesions.
- No dilated intra-hepatic biliary radicles.
- Normal caliber patent Portal Vein
- Partially contracted gallbladder. Few small hyperdense stones inside.
- Normal size, shape and parenchymal density of the pancreas. No enhancing lesions.
- Normal size, shape and density of the spleen. No focal lesions.
- Normal size, and contrast excretion by both kidneys. Normal parenchymal thickness. No renal, masses stones or back pressure changes.
- Normal both supra-renal glands, no masses.
- No ascites
- Normal aorta, I.V.C.
- Normal filling of the urinary bladder with smooth inner surface and uniform wall thickness.
- Degenerative changes of the scanned bones, No aggressive bony lesions.

CONCLUSION:

- No detected suspicious pulmonary or hepatic deposits.

Dr, Ibrahim El Gaml, MD